Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

SUPSI

Disturbi dello Spettro Autistico

21 aprile 2026

Chiara Balerna, Michela Luraschi, Donatella Oggier-Fusi, Piercarla Reposo

Modulo: Percorsi nelle disabilità 2026

Programma della lezione:

- Esplicitazione degli obiettivi della lezione
- Refresh ASD
- Aspetti professionali
- Domande e conclusione

Obiettivi:

- Comprendere le **implicazioni professionali** con persone con ASD
- Riconoscere **alcuni approcci**
- Conoscere le **risorse sul territorio**
- **Sviluppare consapevolezza sulla propria responsabilità educativa**

- “Un mondo in cui la gente ci parla continuamente come se capissimo e invece non capiamo, in cui non sappiamo mai cosa sta per succedere, in cui le cose accadono in modo caotico, senza un ordine, senza prevedibilità, in cui la nostra attenzione è catturata assorbita da oggetti che ruotano, nell’acqua che scorre o da un ventilatore anziché dallo sguardo delle persone, dove la voce di chi parla può trasformarsi in un rumore assordante e la consistenza dei vestiti può essere una tortura per la pelle, dove gli altri giocano un gioco dalle regole incomprensibili e dove niente è chiaro, e vogliono a tutti i costi che partecipiamo anche noi al gioco, anche se non sappiamo dove guardare, come muoverci, qual è la cosa giusta da dire o da fare. Un mondo dove se il nostro oggetto preferito è messo sullo scaffale alto e non siamo in grado di chiedere a un adulto di prendercelo e possiamo solo provare ad arrampicarci senza riuscire a raggiungerlo, un mondo dove se abbiamo il mal di denti non possiamo comunicarlo e ci teniamo il mal di denti soffrendo terribilmente fino a quando qualcuno lo capisce. Un mondo in cui non intuiamo le intenzioni degli altri, non possiamo imparare imitando gli altri, in cui le cose sono frammentate e non riusciamo ad integrarle in un significato coerente, in cui non riusciamo a spostare l’attenzione da una cosa all’altra, in cui la mente si fissa su frasi movimenti che per gli altri hanno un senso, un mondo in cui gli altri capiscono al volo e noi invece dobbiamo fare fatica a capire, in cui gli altri riescono di getto noi invece dobbiamo esercitarci.“

Villa e Vivanti (2007), in Vivanti la mente autistica 2010, pag.124

le persone con DSA non si curano ma si educano

- Pur **non potendo guarire dall'autismo**, molto si può fare per sostenere lo sviluppo e migliorare la qualità di vita delle persone nello spettro

Una considerazione importante

La persona con autismo è di per sé “disarmonica” poiché vi sono anche diverse abilità e capacità nella stessa persona (ad esempio parla molto bene da un punto di vista linguistico ma non sa porre domande).

E’ importante definire però che ogni persona è diversa e quindi non sarà tanto la diagnosi medica a definire il lavoro dell’operatore ma quella **funzionale.**

Si osservano e descrivono **le modalità di funzionamento delle abilità di una persona** e lo stato psico-fisico. Tiene in considerazione la condizione di disabilità e gli effetti che questa ha sulla persona…

Una considerazione importante

…e considera:

- **l'insieme delle disabilità e delle difficoltà** derivanti dalla menomazione stessa o derivanti da contesti sociali e culturali;
- **il quadro generale delle capacità** (con particolare attenzione alla recuperabilità ed ai residui funzionali);
- **le potenzialità di sviluppo** sulle quali elaborare un successivo intervento educativo.

L'educatore negli interventi educativi

- Nella realizzazione e nello svolgimento del PEI considera le strategie e gli approcci finalizzati a sviluppare molteplici **competenze*:**

- **abilità motorie**
- **autonomie personali**
- **apprendimenti scolastici**
- **abilità sociali***
- **comunicazione***

L’educatore negli interventi educativi

le **competenze** comprendono un insieme più ampio di capacità, conoscenze e comportamenti adattabili a diversi contesti.

- Keller (2021) le definisce “il possesso di capacità complesse derivanti non solo dalla somma delle singole abilità sociali ma comprendenti, in una dimensione più olistica, la capacità di esperire e gestire le relazioni sociali personali e interpersonali attraverso l’acquisizione di conoscenze, coscienza e padronanza di significati, dei vissuti e delle relazioni emotive, e attraverso lo sviluppo delle capacità e delle funzioni metacognitive.

L’educatore negli interventi educativi

Le competenze sociali sono un concetto ampio che coinvolgono conoscenze, valori e atteggiamenti.

Ad esempio, la competenza potrebbe includere non solo il saper comunicare, ma anche saper applicare questa capacità in un ambiente lavorativo.

L’educatore negli interventi educativi

Le **abilità sociali** sono comportamenti specifici che possono essere appresi al fine di instaurare positivamente delle relazioni ed interagire in maniera efficace.

Castaldo et al. (2021) le dividono in 2 aree:

- le abilità strumentali, quelle abilità che sono utilizzate per generare una reciprocità nella relazione con l’altro;

- le abilità di relazione, che sono quelle che permettono di instaurare e mantenere un rapporto con le altre persone e che prevedono che la persona sappia interpretare e rielaborare le emozioni in relazione ai diversi contesti di vita

L’educatore negli interventi educativi

Sempre secondo l’autrice vi sono dei fattori che vanno ad ostacolare lo sviluppo delle competenze sociali nelle persone con ASD:

- Fattori neurobiologici: i disturbi del neurosviluppo possono infatti compromettere alcune funzioni metacognitive che vanno ad ostacolare un adeguato sviluppo delle competenze sociali
- Comorbidità di disturbi psichiatrici come ansia e depressione
- Mancanza di motivazione: in alcuni casi può essere sufficiente a non far instaurare dalla persona dei rapporti sociali, anche a seguito di ripetuti e fallimentari tentativi socializzanti

- **Lavora sulla comunicazione**, cioè:

  - Svolge valutazioni specifiche in ambito comunicativo
  - Insegna i pre-requisiti della comunicazione

I prerequisiti sono:

Percezione sensoriale: ascoltare i suoni e osservare il movimento, come le espressioni facciali e i gesti. La percezione uditiva è essenziale per riconoscere i suoni del linguaggio.

Interazione sociale: L'attitudine a interagire con gli altri è fondamentale per acquisire le abilità comunicative, trovare interesse per gli altri e per il mondo che ci circonda.

Imitazione: I bambini imparano gran parte del linguaggio attraverso l'imitazione di parole, suoni e gesti

Gestualità: Prima di utilizzare il linguaggio verbale, i bambini comunicano attraverso gesti, come indicare o tendere le mani.

Attenzione condivisa: La capacità di concentrarsi sugli stessi oggetti o eventi insieme a un'altra persona è cruciale per lo sviluppo della comunicazione. Ad seguire il dito di un altro per guardare un oggetto.

Intento comunicativo: sviluppare il desiderio di comunicare, sia per esprimere bisogni che per condividere emozioni.

Sviluppo cognitivo: Le abilità cognitive, come il riconoscimento di pattern, l'associazione di idee e la memoria, supportano l'apprendimento del linguaggio e la costruzione di frasi.

- lavora sulla comunicazione, cioè:

  - Insegna possibili forme comunicative alternative e/o di supporto al verbale
  - Insegna le funzioni comunicative

Michael Halliday (1975-1980), linguista britannico, ha individuato sette funzioni linguistiche che i bambini sviluppano nel loro apprendimento del linguaggio:

- *Strumentale*: Per soddisfare bisogni materiali (es. "Voglio").
- *Regolatoria*: Per controllare il comportamento degli altri (es. "Fallo").
- *Interazionale*: Per stabilire relazioni (es. "Ciao").
- *Personale*: Per esprimere opinioni o emozioni (es. "Mi piace").
- *Euritmica*: Per esplorare il linguaggio creativo (es. filastrocche).
- *Referenziale*: Per dare informazioni (es. "È rosso").
- *Immaginativa*: Per creare mondi immaginari (es. storie inventate).

L’educatore negli interventi educativi

Tali approcci si differenziano da altri interventi educativi per:

- il tempo che prevedono: **spazi quotidiani ripetuti (trainig)**
- la metodologia di lavoro **orientata pedagogicamente** e quindi più direttiva
- le figure coinvolte, **non solo figure “tecniche” ma anche i genitori e tutte le persone coinvolte nella rete**.

- Tratta i **comportamenti problema** come comportamenti con funzioni comunicative, attraverso interventi di natura educativa che hanno come obiettivo quello di sostituirli con comportamenti funzionali.

Per questo effettua **valutazioni funzionali con relativi strumenti specifici** per cercare di comprendere la struttura e la funzione di un comportamento ed insegnarne uno adeguato e alternativo con la medesima funzione

- Insiste sull'apprendimento di abilità e sulla **strutturazione del tempo**.

- Considera importante l'utilizzo di aspetti motivazionali a favore dell'insegnamento

- Tiene conto delle **peculiarità cognitive dell'autismo** (immagini, agende visive, video modeling, storie sociali,…)

- Tiene conto delle **peculiarità sensoriali** –iper o ipo sensibilità- **ADATTANDO l'ambiente** e cercando strategie che attutiscano o anticipino le possibili difficoltà

- **Adatta, individualizza e struttura la progettazione**

- **Tenta di anticipare**

- Considera l'eventuale **ansia**

- Attribuisce necessariamente attenzione alla relazione con i **genitori,** i quali devono essere adeguatamente informati, guidati e sostenuti nell'organizzazione del sistema famiglia, nelle scelte terapeutiche e negli atteggiamenti affettivo-pedagogici.

Considerare il percorso delle **famiglie per creare un'alleanza educativa**

Quando nasce un figlio non si capisce subito se il bambino ha un disturbo dello spettro autistico. E' solo crescendo, nei primi anni di vita, che la famiglia si pone delle domande e fa dei confronti ed è desiderosa di avere delle risposte nell'accompagnamento della vita adulta.

Vi è la speranza di poter fare qualcosa (guarire?) ma anche delle angosce sul tempo, sulle tecniche, sulle specificità degli interventi.

Vi è la richiesta dei genitori di avere risposte concrete e aiuto per sé stessi, per il bambino (sia informative che istituzionali).

Secondo voi quali sono le differenze tra “noi“ e “loro“?

Visione, bisogni, aspettative, desideri,…

Genitori come risorsa cioè:

- **Coinvolgimento attivo** (valutazioni/PEI/intervento)

- Parent-Training, lavoro diretto per lo sviluppo delle competenze con i genitori
- Considerazione delle priorità famigliari nell'accompagnamento individuale
- Considerazione delle competenze genitoriali

Per un buon patto educativo con le famiglie

I professionisti	I familiari
• sviluppare una relazione basata sulla fiducia • evitare di colpevolizzare i genitori • evitare di ritenerli inadeguati nell‘educazione del figlio • evitare di ritenerli ansiosi o aggressivi • evitare di considerarli avversari • evitare di avere un‘attitudine inquisitoria • evitare di avere un sentimento di solidarietà / pietà • evitare atteggiamenti di giudizio • tenere presente che i professionisti rappresentano guide, non sono gli unici esperti • considerare i bisogni globali della famiglia • saper condividere	• sviluppare una relazione basata sulla fiducia • evitare scetticismo (in seguito ad esperienze già fatte) • non avere il pre-giudizio di non competenza del professionista

Costruire e definire un accompagnamento adeguato nell'ambito dell'autismo **è difficile e faticoso**.

Non possiamo limitarci a buone pratiche, all'esperienze o all'intuizione.

Non possiamo sposare una sola teoria, una sola tecnica e nemmeno affidarci all'improvvisazione.

Una buona pratica educativa in questo ambito si affida ad alcuni **principi** importanti che interagiscono tra di loro:

In sintesi i principi:

1. Diagnosi precoce
2. Obiettivi di intervento individualizzati su: comunicazione, socializzazione e comportamento adattivo
3. Collaborazione famigliari-professionisti, condivisione, valutazioni periodiche dei PEI e aggiustamenti, (progetto di vita)
4. Insegnamento individualizzato, strutturato, “massiccio“ e da parte di tutti
5. Adattamento dell’ambiente
6. Sviluppo delle potenzialità (punti di forza)
7. Applicazione di diversi metodi e approcci
8. Servizi coordinati per l’intero ciclo di vita
9. Conoscenza aggiornata delle peculiarità dell’autismo
10. Conoscenza delle esperienze, dei mezzi e delle “organizzazioni” per l’autismo che hanno già maturato esperienze e fornito risultati
11. **Formazione e scelta del personale**

Depistaggio precoce e osservazione, l'importanza dell'intervento precoce

http://4.bp.blogspot.com/-Fg8jPX6tUAs/T3qpCaI4jTI/AAAAAAAAAGk/bltOAaXJsGg/s1600/autismo+2.gif

Alcuni metodi e approcci, in sintesi:

Approccio comportamentale (ABA)

L'*Applied Behavior Analysis* (Analisi Applicata del Comportamento, ABA), è una scienza che si propone di studiare e descrivere **la relazione che intercorre tra i comportamenti messi in atto dalle persone e l'ambiente che li influenza**

(M. Pignarolo, 2016)

L'ABA trova i suoi principi all'interno della teoria del condizionamento operante di Skinner (1904-1990), secondo cui **il comportamento, ovvero tutto ciò che è osservabile, esercita un'influenza sull'ambiente circostante che a sua volta agisce sulla messa in atto del comportamento stesso**

(Skinner, B.F., 1975).

Ogni intervento avviene all'interno di un setting definito nel tempo, nello spazio e nella relazione tra persone in un rapporto 1:1

Principio fondamentale è **il rinforzo** cioè una conseguenza che rafforza un determinato comportamento, che aumenta la possibilità che esso si verifichi nuovamente in futuro.

Approcci naturalistici (Koegel et alt. 1979)

Sono approcci che si basano sull' analisi applicata del **comportamento** che prevedono l'uso di procedure di **rinforzo** di vari comportamenti, in particolare delle risposte linguistiche**, all'interno di sequenze interattive spontanee e non strutturate**.

Queste sequenze sono basate sulle seguenti caratteristiche:

- l'apprendimento si basa sull'iniziativa comunicativa del bambino e sulla sua richiesta spontanea di un oggetto di un'attività
- l'adulto ricava il comportamento desiderato premiando il bambino in modo contingente con l'oggetto o attività richiesta

Terapia Cognitivo-Comportamentale (Cognitive Behavioral Therapy-CBT)

La terapia cognitivo-comportamentale (CBT) è un trattamento psicoterapeutico ideato da Ellis e Beck negli anni 60 del 900.

Il trattamento fonda le sue radici teoriche sul presupposto **che pensieri, emozioni e comportamenti siano fortemente correlati tra loro, e che alla base del disagio emotivo ci siano degli schemi di credenze e pensieri disfunzionali**, rispetto a sé e all'ambiente. Pertanto, **non sarebbe un evento in sé a creare la sofferenza, ma le singole costruzioni cognitive su tale evento o sull'efficacia nell'affrontarlo.**

Il focus della terapia cognitivo-comportamentale è il riconoscimento degli schemi di pensiero e comportamento disfunzionali, al fine di modificarli e sostituirli con convinzioni più adatte al percorso di vita della persona.

Interventi abilitativi - training

Interventi abilitativi si configurano come procedure tecniche, finalizzate a sviluppare determinate abilità (motorie, prassiche, cognitive, comunicative e linguistiche). Partendo da un bilancio funzionale iniziale, si individuano nell'ambito di ciascuna area prestazionale gli obiettivi specifici e quelli a medio e lungo termine (progetto di vita).

Il conseguimento di tali obiettivi viene quindi realizzato guidando la persona nell'effettuazione di **specifiche esperienze**, attraverso **un percorso le cui tappe sono definite** in rapporto all'età, al livello di sviluppo e alle caratteristiche del profilo comportamentale. (L. Moderato)

Comunicazione aumentativa e alternativa (CAA)

Con la CAA si fa riferimento ad un'area della pratica riabilitativa mirata a compensare i deficit degli individui colpiti da gravi disordini della comunicazione espressiva attraverso l'utilizzo di sistemi simbolici alternativi al codice verbale come immagini, parole scritte, oggetti per comunicare.

Il PECS (Picture Exchange Communication System) è un sistema di CAA usato con le persone con ASD. Esso prevede l'uso di strategie di rinforzo per promuovere l'uso di carte-immagine per richiedere oggetti o attività.

TEACCH (E.Schopler 1972)

L'utilizzo di supporti visivi per la comunicazione è un elemento fondamentale anche del programma TEACCH (Teatment and Education of Autistic and Related Comumunication Handicapped Childern).

In tema cruciale del programma è l'adattamento dell'ambiente (strutturazione) e la strutturazione del tempo alle caratteristiche dell'autismo.

Secondo il metodo una persona con ASD può vivere meglio in un mondo più visivo e meno parlato, più concreto e meno simbolico, più prevedibile e meno caotico.

Approcci evolutivi

Si basano sullo sviluppo delle abilità sociali e pre-verbali come base per lo sviluppo delle altre aree di sviluppo.

Elementi chiave di questo approccio sono lo sviluppo della reciprocità sociale nel bambino, attraverso l'insegnamento di comportamenti come l'attenzione condivisa, l'imitazione e la condivisione dell'affetto all'interno di sequenze di gioco basate sull'iniziativa del bambino.

Tutto cio' ha lo scopo di creare le fondamenta per lo sviluppo linguistico, cognitivo e sociale nei bambini con ASD

Modello DENVER

L'Early Start Denver Model (ESDM) è un modello d'intervento, che viene svolto in un contesto naturalistico ed è rivolto a bambini con SDA dai 12 mesi in poi. È stato sviluppato nei primi anni 2000 all'universtità di Washington (S. Rogers, G. Dawson). Questo modello **integra gli elementi dell'analisi applicata del comportamento e delle teorie di sviluppo**.

Il programma si basa sul parent training (insegnamento e supervisione ai genitori) e mira ad insegnare ai genitori strategie specifiche che promuovano nel bambino l'interazione affettiva, la reciprocità sociale, lo sviluppo di attenzione condivisa, l' limitazione e l'intenzionale uso comunicativo di segni di gesti e parole e del gioco funzionale e simbolico. Questo non serve a correggere i genitori bensì insegnare precise procedure.

La motivazione del bambino viene ottenuta attraverso l'integrazione delle sue scelte negli episodi di insegnamento, alternando compiti già acquisiti a quelli non ancora acquisiti e permettendo un controllo condiviso e alternato dei materiali dell'interazioni. **La comunicazione spontanea è specificatamente incoraggiata** e r**inforzata** e gli atti comunicativi del bambino esercitano controllo sull'interazione. Il bambino ha la cosi' la possibilità di sperimentare e apprezzare il potere delle proprie comunicazioni.

Interventi farmacologici / medicamenti

Non ci sono medicamenti per l'autismo, quello che fa la ricerca è di di provare con le persone con SDA farmaci che si sono rivelati utili per pazienti con altri tipi di patologie. **La terapia farmacologica**, potrebbe quindi essere prescritta **su sintomi**, essa deve sempre essere inserita nell'ambito di un progetto terapeutico globale (da un medico preferibilmente specializzato), che prenda in considerazione i molteplici bisogni del soggetto; è indispensabile chiarire ai genitori il significato e i limiti della terapia e la **collaborazione con la rete**.

Ciò risponde non solo ad un obbligo deontologico, ma anche al bisogno di una partecipazione consapevole dei genitori, la quale permette di valutare la validità delle terapie suggerite.

IN SINTESI: Il ruolo dell'operatore

L'intervento educativo mette al centro dell'accompagnamento delle persone con ASD l'operatore. La qualità del lavoro dell'operatore incide direttamente sulla qualità di vita dell'utente.

L'operatore è chiamato ad interagire con diverse entità collegate tra di loro, l'utente, la famiglia, la rete di professionisti e la società

Le sue responsabilità sono importanti e deve rendere conto del proprio lavoro sia ai familiare che all'ente di appartenenza.

Oltre a ciò veicola l'immagine dell'autismo e deve quindi costantemente essere **informato** sull'evoluzione dei concetti.

Difficoltà per l'operatore

- Difficoltà a selezionare le informazioni nelle varie correnti e nei differenti miti nati negli anni
- Difficoltà a valutare le informazioni selezionate
- Difficoltà a comprendere e spiegare il disturbo (a sé e a terze persone)
- Difficoltà a interagire con le famiglie e con i colleghi sul tema autismo
- Difficoltà a motivarsi per determinati tipi di intervento
- Difficoltà a seguire linee guida/intervento istituzionali sull'autismo (se non specificate e condivise)

Rischi per l'operatore

- Priorità a ciò che "vende" una prognosi migliore
- Terapie di moda / applicazioni parziali e/o improvvisata di modelli validi
- Terapie prive di risultati "quantificabili"
- Visione a corto termine
- Fiducia/dipendenza da altri professionisti (psichiatra, ecc…)
- Creazione di situazioni «avversive» inconsapevolmente
- Forme di «assistenzialismo» e non intervento adeguato
- Esclusione della famiglia dall'intervento educativo
- Scelte educative a seconda della propria percezione di «autismo»

In Ticino il centro di competenza per l'autismo è la Fondazione Ares

- Promuove la cultura sull'autismo trammite eventi e documentazione
- Offre diversi servizi specializzati
- Pubblica libri a altro materiale di approfondimento e aggiornamento
- Visitare il sito: Fondazioneares.com

Bibliografia:

National Institute of Mental Health (2004): *Disturbi Pervasivi dello Sviluppo:* Breve descrizione dei sintomi, cause e trattamenti, con informazioni su come ottenere aiuto e supporti pratici. *Pubblicazione NIH No.04-5511 Aprile (Traduzione in italiano: Anna M. Kozarzewska-Bigazzi Supervisione della versione italiana: D. Vivanti)*

Autisme Europe (2006) *Sensibilisation à l'autisme*. Autism-Leaflet-Awareness 10/08/06; Bruxelles

Autisme Europe / Barthélémy, Fuentes, Howlin, van der Gaag (2010) Les personnes atteintes d'autisme. Identification, compréhension, intervention, Autisme Europe, Bruxelles

Autisme Europe (1998) Code de bonnes Pratiques pour la Prévention de la Violence aux Personnes atteintes d'Autisme.

Angel Rivière (1996) Sono affetto da autismo. Ecco cosa vorrei dirti (traduzione italiana (ONLUS)

La mente autistica, G. Vivanti (2010)

Modello superability. Un approccio globale alle disabilità intellettive, ai disturbi pervasivi dello sviluppo e all'autismo; L. Moderato (2009)

Romina Castaldo, Stefania Bari, Gabriella Tocchi, & Roberto Keller. (2021). *Manuale di social skills training nell'intervento con persone con autismo in adolescenza ed età adulta*. Edra.

Keller, R. (A c. Di) (con un contributo di Zappella, M.). (2021). *I disturbi dello spettro autistico in adolescenza e in età adulta: Aspetti diagnostici e proposte di intervento*. Erickson.

Vivanti, G. (con un contributo di Cornoldi, C.). (2021). *La mente autistica: Le risposte della ricerca scientifica all'enigma dell'autismo* (2 . ed). Hogrefe.

Rivista: autismo oggi, Fondazione Ares

Sito: www.fondazioneares.com